

1. Introducción y relevancia clínica

El **delirium** (también denominado **síndrome confusional agudo**) es una **alteración aguda y fluctuante del nivel de conciencia y la atención**, acompañada de **trastornos cognitivos y perceptivos**, secundaria a una **causa médica, farmacológica o ambiental identificable**.

Es una **emergencia geriátrica** frecuente, reversible en la mayoría de los casos, pero con **alta mortalidad** si no se reconoce y maneja a tiempo.

Epidemiología

- Afecta al **15–25% de los pacientes hospitalizados mayores de 65 años**.
- En unidades críticas, la incidencia puede superar el **50%**.
- En Chile, el **MINSAL** lo incluye dentro de los **síndromes geriátricos prioritarios** en hospitales y residencias.

Relevancia clínica

- Asociado a **duplicar la estancia hospitalaria** y **aumentar 3 veces la mortalidad intrahospitalaria**.
- Es causa frecuente de **consultas psiquiátricas en pacientes hospitalizados**.
- A menudo **coexiste con demencia**, lo que dificulta el diagnóstico.

□ En **EUNACOM**, el delirium suele presentarse como un **cuadro agudo de desorientación, inatención o agitación en un adulto mayor hospitalizado**, donde se debe diferenciar de demencia y depresión.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El delirium refleja una **disfunción cerebral aguda y generalizada** causada por múltiples factores.

2.1. Mecanismos neurobiológicos

- **Déficit colinérgico:** reducción de acetilcolina en la corteza y el sistema reticular → afecta atención y memoria.
- **Exceso dopaminérgico:** hiperactividad dopaminérgica contribuye a alucinaciones y agitación.
- Alteraciones en **serotonina, GABA y glutamato**, que modifican el estado de alerta.
- **Neuroinflamación:** citocinas (IL-1, TNF- α) y estrés oxidativo alteran la función neuronal.

2.2. Factores predisponentes (vulnerabilidad basal)

- Edad avanzada (>65 años).
- **Demencia o deterioro cognitivo previo.**
- Enfermedades neurológicas (ACV, Parkinson).
- Polifarmacia (≥ 5 fármacos).
- Déficit sensorial (audición o visión).
- Fragilidad o malnutrición.

2.3. Factores precipitantes

- Infecciones (ITU, neumonía, sepsis).
- Deshidratación o trastornos electrolíticos (hiponatremia, hipocalcemia).
- Fármacos (benzodiazepinas, opioides, anticolinérgicos).
- Cirugía y anestesia general.
- Dolor, inmovilización, privación de sueño.
- Retención urinaria o fecal.

□ El delirium surge típicamente de una **combinación entre vulnerabilidad basal y un factor precipitante agudo.**

Ejemplo clásico: “anciano con demencia leve que desarrolla confusión tras una infección urinaria”.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Características clínicas cardinales

El **DSM-5** define delirium por los siguientes criterios:

1. **Alteración de la atención y conciencia** (inatención, distractibilidad, dificultad para mantener la conversación).
2. **Inicio agudo (horas a días)** y curso **fluctuante** a lo largo del día.
3. **Alteración cognitiva adicional:** memoria, orientación, lenguaje, percepción (alucinaciones).
4. No explicable por demencia ni otro trastorno neurocognitivo.
5. Causa fisiológica identificable (médica, tóxica o metabólica).

3.2. Tipos clínicos de delirium

Tipo	Características	Frecuencia
Hiperactivo	Agitación, alucinaciones visuales, agresividad, insomnio.	25%
Hipoactivo	Letargia, somnolencia, enlentecimiento, poco contacto.	50%
Mixto	Alternancia entre ambos estados.	25%

☐ El **delirium hipoactivo** es el más frecuente y el más **subdiagnosticado**, especialmente en adultos mayores.

3.3. Síntomas más comunes

- **Cognitivos:** desorientación, dificultad de atención, memoria reciente alterada.
- **Perceptivos:** ilusiones o alucinaciones visuales.
- **Conductuales:** agitación, irritabilidad, o bien inhibición y somnolencia.

- **Del sueño:** inversión del ritmo circadiano.
 - **Emocionales:** miedo, ansiedad, labilidad afectiva.
-

3.4. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características diferenciales
Demencia	Inicio lento, progresivo; conciencia conservada; curso estable.
Depresión ("seudodemencia")	Inicio subagudo; queja subjetiva exagerada; sin fluctuaciones.
Psicosis primaria	Sin alteración de conciencia; alucinaciones auditivas predominan.
Trastornos metabólicos graves	Causan delirium secundario; se identifican con laboratorio.

□ En **EUNACOM**, una clave diagnóstica es el **inicio agudo + fluctuación + alteración de la atención**, lo que descarta demencia.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **fundamentalmente clínico**, apoyado por instrumentos de cribado.

Herramientas de evaluación:

- **CAM (Confusion Assessment Method):**

Diagnóstico si hay:

1. Inicio agudo y curso fluctuante y

2. Inatención y

3. (Pensamiento desorganizado o alteración del nivel de conciencia).

- **4AT (4 A's Test):** útil en APS y urgencias.

Evalúa: alerta, atención, fluctuación y desorientación.

Puntuación $\geq 4 \rightarrow$ alto riesgo de delirium.

4.2. Exámenes básicos recomendados

Solicitar siempre:

- Hemograma, electrolitos, glicemia, creatinina, BUN.
- TSH, calcio, magnesio.
- EGO / urocultivo (descartar ITU).
- Radiografía de tórax.
- ECG (si hay fármacos prolongadores de QT).
- TAC cerebral si:
 - Focalidad neurológica nueva.
 - Traumatismo craneal.
 - Fiebre sin foco o sospecha de ACV.

☐ Buscar **la causa subyacente** es el objetivo principal del estudio.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo del delirium es **una urgencia médica**.

Debe abordarse en tres pilares:

1. **Tratamiento de la causa.**

2. **Medidas no farmacológicas.**
 3. **Control sintomático farmacológico (si es necesario).**
-

5.1. Tratamiento etiológico

- Tratar la **causa precipitante**: infección, deshidratación, hipoxia, fármaco, dolor, constipación, etc.
- Suspender fármacos potencialmente desencadenantes:
 - Benzodiacepinas, opioides, anticolinérgicos, corticoides, digoxina, AINES.

☐ En Chile, MINSAL recomienda el “**Enfoque de las 4C**”: **C**ausa, **C**uidados, **C**ontención y **C**omunicación.

5.2. Medidas no farmacológicas (primera línea)

- **Reorientación frecuente**: recordar fecha, lugar y motivo de hospitalización.
- **Presencia de familiar o cuidador conocido.**
- **Ambiente tranquilo, buena iluminación, reloj y calendario visibles.**
- **Evitar inmovilización física innecesaria.**
- **Favorecer ciclo sueño-vigilia**: luz natural, minimizar ruido nocturno.
- **Usar audífonos o lentes si hay déficit sensorial.**
- **Movilización precoz y fisioterapia.**
- **Hidratación y control del dolor.**

☐ Estas medidas son tan efectivas como el tratamiento farmacológico, y deben implementarse siempre.

5.3. Tratamiento farmacológico (solo si hay riesgo)

Indicado solo en delirium **hiperactivo con agitación o riesgo de daño** al paciente o terceros.

Antipsicóticos (fármacos de elección):

- **Haloperidol:**
 - Dosis: 0,5–2 mg VO/IM cada 4–6 h (máx. 10 mg/día).
 - Preferir vía oral o subcutánea.
 - Controlar QTc → ECG previo si posible.
- **Risperidona:** alternativa oral si se anticipa curso prolongado (0,25–1 mg/día).
- **Olanzapina o quetiapina:** preferibles en Parkinson o cuerpos de Lewy (menor riesgo extrapiramidal).

□ **Evitar benzodiacepinas**, excepto en **delirium por abstinencia alcohólica o benzodiacepínica**.

En ese caso, usar **diazepam** o **lorazepam**.

5.4. Manejo ambiental y de apoyo

- Ubicación en habitación tranquila y bien iluminada.
 - Evitar traslados innecesarios.
 - Mantener hidratación y control del dolor.
 - Supervisión continua por personal capacitado.
 - Participación familiar activa.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- Caídas, fracturas.
- Deshidratación y desnutrición.

- Neumonía aspirativa.
- Úlceras por presión.
- Prolongación de la hospitalización.
- **Mortalidad intrahospitalaria:** 10–25%.

6.2. Pronóstico

- Con tratamiento oportuno, la mayoría de los casos **revierte en días a semanas**.
- Sin tratamiento, puede progresar a **deterioro cognitivo persistente o muerte**.
- Mayor riesgo de **demencia futura**: 2–4 veces más probable tras un episodio de delirium.

Factores de mal pronóstico:

- Edad avanzada.
- Demencia previa.
- Curso prolongado o hipoactivo.
- Causas infecciosas o metabólicas graves.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. El **delirium** tiene **inicio agudo y curso fluctuante**, a diferencia de la demencia.
2. El **síntoma cardinal** es la **inatención** (más útil que la desorientación).
3. En adultos mayores, la **infección urinaria o neumonía** es la causa más frecuente.
4. El **delirium hipoactivo** es el más común y el más subdiagnosticado.

5. **Haloperidol** es el antipsicótico de elección, pero se debe **evitar en Parkinson o Lewy**.
 6. El tratamiento debe incluir **identificar y corregir la causa precipitante**, no solo sedar.
 7. **Evitar benzodiacepinas**, salvo en abstinencia alcohólica.
 8. La **prevención** (reorientación, ambiente, movilización) es la intervención más efectiva.
-



Errores comunes

- Diagnosticar demencia en un paciente con delirium (por inicio agudo olvidado).
 - Usar benzodiacepinas sin indicación.
 - No corregir la causa de base.
 - Falta de reorientación y aislamiento del paciente.
 - Indicar haloperidol IV sin monitoreo ECG.
 - Olvidar buscar causas reversibles: infección, hiponatremia, fármacos.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **delirium** es un síndrome agudo y reversible de alteración de la atención y conciencia, frecuente en adultos mayores.
2. Su diagnóstico es **clínico**, basado en inicio agudo, fluctuación y desatención.
3. La **causa médica subyacente** (infección, fármaco, deshidratación, hipoxia) debe identificarse y corregirse de inmediato.
4. El manejo inicial debe priorizar **medidas no farmacológicas y apoyo ambiental**.

5. Los **antipsicóticos (haloperidol)** se usan solo en agitación o riesgo, con precaución en pacientes con Parkinson o cuerpos de Lewy.
6. **Evitar benzodiacepinas**, salvo en delirium por abstinencia alcohólica.
7. La **prevención y detección temprana** reducen significativamente la mortalidad y el deterioro cognitivo.